

Critérios de testagem genética em oncologia

Quem testar, o que testar e em que momento da doença, por sítio tumoral — com a diretriz que sustenta cada critério.

Versão de 12 de agosto de 2026 · 7 sítios tumorais

Ovário, tuba uterina e peritônio

QUEM TESTAR

- **Teste germinativo:** todo carcinoma epitelial, ao diagnóstico — independentemente de idade, estágio ou história familiar.
- **Teste somático (HRD):** carcinoma **seroso ou endometrióide de alto grau**, estágio **FIGO III ou IV**.

O QUE TESTAR

Painel germinativo BRCA1/2 — sangue periférico.

HRD somático — tecido tumoral. Inclui BRCA1/2 tumoral no mesmo teste. Define elegibilidade a manutenção com inibidor de PARP.

Fora do critério: tumor borderline (baixo potencial de malignidade) não é carcinoma invasivo e está fora do espectro BRCA-associado. Histologias não epiteliais seguem outra diretriz.

DIRETRIZ

NCCN Ovarian Cancer, Fallopian Tube Cancer and Primary Peritoneal Cancer · NCCN Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian, Pancreatic and Prostate (v2.2026) · SGO Clinical Practice Statement on Genetic Testing in Ovarian Cancer · ESMO-ESGO Consensus.

Mama

QUEM TESTAR

- **Teste germinativo** — basta *um* destes critérios:
 - Paciente do **sexo masculino**, em qualquer idade.
 - Diagnóstico aos **50 anos ou menos**, qualquer subtipo.
 - Subtipo **triplo-negativo**, em qualquer idade.
 - **Doença metastática**, qualquer subtipo.
 - **História familiar** oncológica relevante.
- **Teste somático:** doença **metastática luminal** (RH+/HER2-).

O QUE TESTAR

Painel germinativo BRCA1/2, PALB2 e genes de alto risco — sangue periférico. Define elegibilidade a inibidor de PARP em cenário adjuvante de alto risco e metastático.

Painel somático PIK3CA, ESR1 e alvos acionáveis — tecido tumoral ou biópsia líquida. ESR1 deve ser reavaliado à progressão sob terapia endócrina.

Ponto em aberto: o corte etário em uso é **50 anos** (NCCN). A ASCO-SSO recomenda oferecer teste germinativo a todo paciente diagnosticado aos **65 anos ou menos** — critério mais largo. Decisão pendente de validação.

DIRETRIZ

NCCN Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian, Pancreatic and Prostate (v2.2026) · ASCO-SSO "Germline Testing in Patients With Breast Cancer" — Journal of Clinical Oncology, 2024 (DOI 10.1200/JCO.23.02225).

Próstata

QUEM TESTAR

- **Teste germinativo** — basta *um* destes critérios:
 - **Doença metastática**, hormônio-sensível (mHSPC) ou resistente à castração (mCRPC).
 - **Linfonodo positivo** (N1).
 - Doença localizada de risco **alto ou muito alto**.
 - Histologia **intraductal ou cribriforme**, em qualquer risco.
 - **Ascendência judaica Ashkenazi**.
 - **História familiar** oncológica relevante.
- **Teste somático (HRR):** doença **metastática**.

O QUE TESTAR

Painel germinativo BRCA1/2, ATM, CHEK2, PALB2, HOXB13 e genes de MMR — sangue periférico.

Painel somático HRR (15 genes) — tecido tumoral ou biópsia líquida. BRCA1/2, ATM, BARD1, BRIP1, CDK12, CHEK1/2, FANCL, PALB2, PPP2R2A, RAD51B/C/D, RAD54L. Define elegibilidade a inibidor de PARP. Alteração HRR presente em 27,9% dos casos metastáticos (PROfound).

Ponto em aberto: risco **intermediário desfavorável** não dispara o teste germinativo na regra atual. Confirmar se deve entrar.

DIRETRIZ

NCCN Prostate Cancer · NCCN Genetic/Familial High-Risk Assessment (v2.2026) · AUA/SUO Advanced Prostate Cancer Guideline · EAU-EANM-ESTRO-ESUR-ISUP-SIOG Guidelines on Prostate Cancer · Estudo PROfound (de Bono et al., NEJM 2020).

Colorretal

QUEM TESTAR

- **MMR / MSI: todo** carcinoma colorretal, ao diagnóstico — independentemente de idade ou história familiar.
- **Painel germinativo multigênico:** diagnóstico **abaixo dos 50 anos** — independentemente do status de MMR e de história familiar.
- **Painel germinativo de Lynch:** tumor **dMMR / MSI-alto**.
- **Perfil somático:** doença **metastática**.

O QUE TESTAR

Pesquisa de MMR / MSI — tecido tumoral, por imuno-histoquímica das proteínas de reparo ou análise de instabilidade de microssatélites. Informa prognóstico, elegibilidade a imunoterapia e risco familiar.

Painel germinativo multigênico — sangue periférico. APC, MUTYH, genes de Lynch, BMPR1A, SMAD4, PTEN, STK11. Variante germinativa patogênica em cerca de 1 a cada 6 pacientes com colorretal.

Painel germinativo de Lynch — sangue periférico. MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM. Perda isolada de MLH1 exige antes afastar causa esporádica (metilação do promotor ou BRAF V600E).

Perfil somático RAS, BRAF V600E e HER2 — tecido tumoral ou biópsia líquida. Obrigatório antes de terapia anti-EGFR.

DIRETRIZ

NCCN Colon Cancer · NCCN Rectal Cancer · NCCN Genetic/Familial High-Risk Assessment: Colorectal, Endometrial and Gastric (v2.2026).

Pulmão — não pequenas células

QUEM TESTAR

- **Doença ressecável** (estágio IB a IIIB): pesquisa dirigida para decisão adjuvante, **antes de a doença avançar**.
- **Doença localmente avançada ou metastática:** painel molecular amplo **antes de definir a primeira linha**.

O QUE TESTAR

EGFR, ALK e PD-L1 — tecido tumoral (peça cirúrgica). EGFR e ALK definem elegibilidade a terapia-alvo adjuvante; PD-L1 orienta a imunoterapia adjuvante.

Painel molecular amplo — tecido tumoral ou biópsia líquida. EGFR, ALK, ROS1, BRAF, KRAS G12C, MET, RET, NTRK e HER2. Testar gene a gene consome tecido e atrasa a decisão terapêutica.

Janela adjuvante: adiar o teste em doença ressecável para depois da progressão perde a indicação adjuvante, cujo benefício em sobrevida livre de doença não é recuperável na doença avançada. **Fora do critério:** carcinoma de pequenas células segue via clínica distinta.

DIRETRIZ

NCCN Non-Small Cell Lung Cancer (v2.2026) · Estudo ADAURA — osimertinibe adjuvante em EGFR mutado (Wu et al., NEJM 2020; Tsuboi et al., NEJM 2023) · Estudo ALINA — alectinibe adjuvante em ALK rearranjado (Wu et al., NEJM 2024).

Pâncreas

QUEM TESTAR

- **Teste germinativo: todo** adenocarcinoma ductal (PDAC), ao diagnóstico — independentemente de idade, estágio ou história familiar.
- **Perfil somático:** doença **metastática**.

O QUE TESTAR

Painel germinativo BRCA1/2, PALB2, ATM e genes de MMR — sangue periférico.

Perfil somático tumoral — tecido tumoral. Identifica alvos acionáveis e confirma alterações em genes de reparo quando o germinativo é negativo.

Por que a indicação é universal: em série de 854 pacientes com PDAC, apenas 3 de 33 portadores de mutação deletéria (9%) tinham história familiar relevante — triar por história familiar deixa passar 91% dos portadores. **Fora do critério:** tumor neuroendócrino de pâncreas segue outra diretriz.

DIRETRIZ

NCCN Pancreatic Adenocarcinoma · NCCN Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian, Pancreatic and Prostate (v2.2026).

Endométrio

QUEM TESTAR

- **Classificação molecular: todo** carcinoma de endométrio — independentemente de idade, grau ou estágio.
- **Painel germinativo de Lynch:** tumor **dMMR**.

O QUE TESTAR

Classificação molecular completa — tecido tumoral. MMR/MSI por imuno-histoquímica, sequenciamento do domínio exonuclease de **POLE**, e imuno-histoquímica de **p53**.

Painel germinativo de Lynch — sangue periférico. MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM.

MMR sozinho não fecha a classificação. O algoritmo é hierárquico — POLE prevalece sobre MMRd, que prevalece sobre p53 anormal — então um tumor pMMR ainda pode ser POLEmut ou p53 anormal, grupos com prognóstico oposto entre si e conduta adjuvante distinta.

DIRETRIZ

NCCN Uterine Neoplasms (v2.2026) · ESGO/ESTRO/ESP Guidelines for the Management of Patients with Endometrial Carcinoma (2025) · NCCN Genetic/Familial High-Risk Assessment: Colorectal, Endometrial and Gastric (v2.2026).

Vias de acesso sem custo

Programas patrocinados pela indústria, verificados em agosto de 2026. A elegibilidade do programa pode ser mais estreita que a indicação clínica.

SÍTIO	PROGRAMA E CONDIÇÃO
Ovário	Teste HRD sem custo — GSK, metodologia myChoice CDx Elegível: seroso ou endometriode de alto grau de ovário, tuba uterina ou peritônio, em primeira linha de tratamento. A solicitação não é por portal — o médico pede ao laboratório parceiro, que inscreve a paciente e encaminha os blocos.
Pulmão	Mapeamento Pulmão — consórcio AstraZeneca, Bayer, BMS, Pfizer e Roche Perfil genômico completo sem custo em não pequenas células, por painel abrangente. Inclusão pelo serviço de patologia ou pelo representante da indústria.
Ovário, mama, próstata, pulmão	ProgramAID — AstraZeneca Teste sem custo em tecido tumoral. Resultado inconclusivo permite reteste por biópsia líquida sem custo adicional.
Próstata	Apoio diagnóstico — Pfizer Vinculado à terapia com inibidor de PARP. Portal oficial a confirmar — consultar o representante antes de encaminhar.
Colorretal, pâncreas, endométrio	Sem programa patrocinado localizado Busca realizada em agosto de 2026 sem resultado. Registrado como busca sem resultado, não como inexistência confirmada.

MÉDICO RESPONSÁVEL PELA
VALIDAÇÃO

CRM

DATA

Este documento descreve critérios de triagem para **indicação de exame genético**. Não constitui recomendação terapêutica nem substitui aconselhamento genético — casos com critério para síndrome hereditária devem ser encaminhados ao especialista. As diretrizes citadas são as vigentes na data desta versão e devem ser reconfirmadas a cada revisão.